一页临床路径 | NMOSD 诊断与治疗

2025 · 条件与下一步按原文整理；诊断细则和特殊分支见提取表

1 疑似或新发 / 加重症状

双眼视功能＋脑 / 脊髓 / 眼眶 MRI；尽量免疫治疗前采血 CBA。新 / 加重症状 >24 h 需区别感染等假性复发。疑似→ 2；不支持→ 4。

2025 p688–689、691、693–694

疑似 NMOSD

2 按 AQP4-IgG 分层诊断

阳性：≥ 1 项核心特征＋可靠检测＋排除其他诊断。阴性 / 未知：≥ 2 项不同核心特征＋指定核心症候＋ MRI 附加条件，详见提取表。符合→ 3；不符→ 4。

2025 p692

不支持 / 假性复发

符合诊断且急性发作

4 复核、鉴别与动态随访

核查 MS、MOGAD、缺血、感染及肿瘤等；仅脑脊液 AQP4 阳性不足确诊；双抗体阳性须复检。纠正假性复发诱因，重评临床和影像后返回 2。

2025 p689–691、693–694

3 确诊急性发作立即治疗

IVMP 1 g/d×3–5 d 后按原文减量。最初几天反应不佳或中重度 / 严重视神经炎，尽早血浆置换 / 免疫吸附。急性视神经炎不推荐 IVIG。稳定→ 5。

2025 p693–694

5 启动长期预防复发

AQP4 阳性：确诊即尽早长期治疗。阴性：第 1 次严重或第 2 次发作后考虑。选药前 HBV/ 结核筛查；依库珠首剂前 2 周接种脑膜炎球菌疫苗。

2025 p691、694–698

长期管理

6 监测后继续或调整

EDSS 每 3–6 个月；MRI/AQP4 每 6–12 个月。>1 年出现 1 次严重或≥ 2 次复发，或不耐受 / 妊娠等，考虑转换机制。疑似新发作返回 1。

2025 p697–698

跨行分支： 2→4 不符合 / 证据不足； 4→2 复核后再评估； 3→5 稳定后衔接

节点内条件优先；未列阈值不补编。完整证据、禁忌与特殊人群见提取表。